



UFPA

A Inteligência Local no Combate à Sepsé

Perfil Epidemiológico e Impacto do Protocolo 'Hora de Ouro'
no Hospital Regional Norte (HRN)

DATASET: 1.360 Prontuários

PERÍODO: Jan/2019 — Fev/2020

LOCAL: Sobral, Ceará

Baseado na dissertação de
Aldenir Rocha de Oliveira Filho

A Ameaça Global e Nacional



50 Milhões
de casos globais
anuais (11M de óbitos).

30%
de prevalência nas
UTIs brasileiras.

Alert Amber

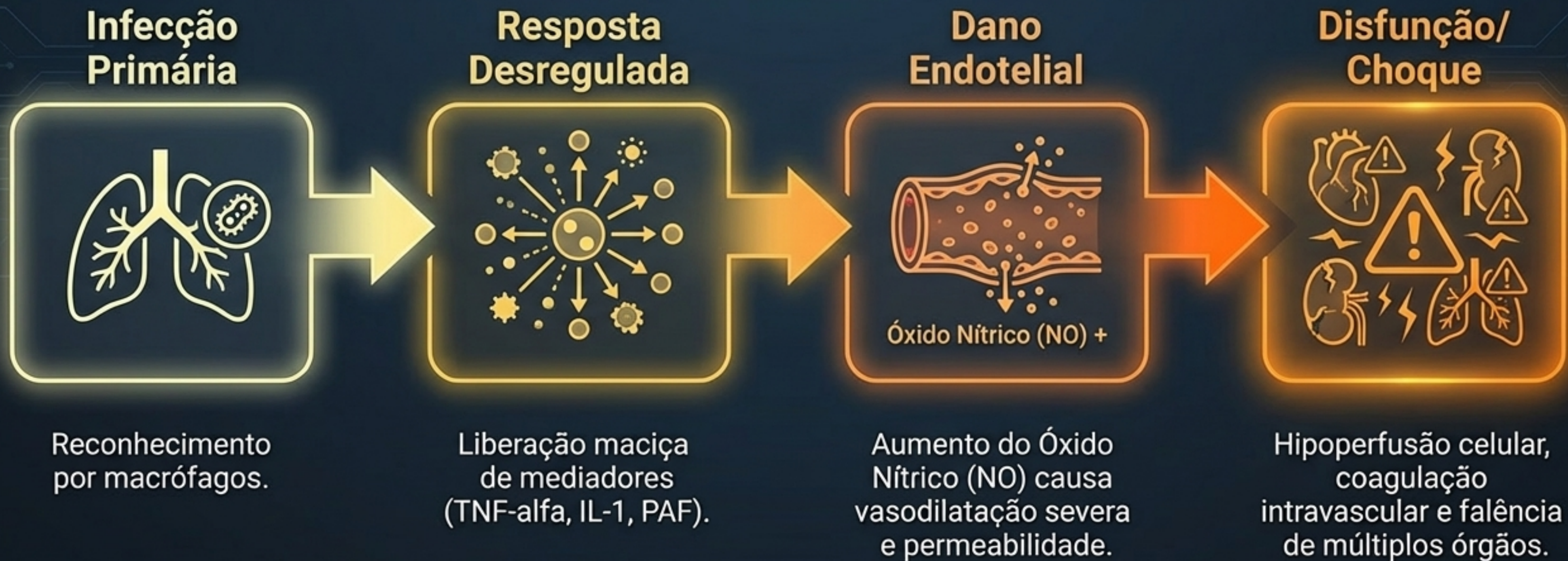
Até 55%
de mortalidade no
Brasil devido à baixa
disponibilidade de
recursos.

A Necessidade Local



- Apesar do impacto avassalador, os dados sobre a realidade de hospitais no interior do Nordeste são escassos. O protocolo global só salva vidas se adaptado à nossa demografia.
- O HRN atende 1,6 milhão de pessoas na macrorregião Norte.

A Cascata da Sepses



O Perfil do Paciente Séptico no HRN

SEXO:

Maioria Masculina
(51,69%)



ORIGEM DA INFECÇÃO:

Comunitária (67,13%) vs.
Hospitalar (16,25%).



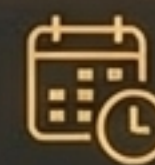
COMORBIDADES:

Escala de Charlson
Média = 2,09 pontos
(Doença de base significativa).



IDADE MÉDIA:

50,4 Anos
(Mediana: 56 anos).



Atenção: Idade mais baixa do que a média de outras UTIs (61-64 anos), reflexo do amplo escopo de atendimento do HRN.



Focos Iniciais Primários

Pulmonar: 53,67%

Abdominal: 21,64%

Pele e Partes Moles: 8,65%

Urinário: 4,32%

Corrente Sanguínea: 2,00%

Perinatal: 0,20%

Foco majoritário, frequentemente associado a pneumonia e necessidade ventilatória

A predominância pulmonar e origem comunitária exigem alta suspeição clínica na porta da Emergência para síndromes respiratórias.

Espectro de Gravidade (HRN)

Infeção Sem Disfunção

Prevalência: 8,97%

Resposta localizada em controle.

Sepse

Prevalência: 82,94%

Disfunção orgânica presente.

Choque Séptico

Prevalência: 8,08%

Necessidade de vasopressores (PAM $\geq$ 65 mmHg) e Lactato > 2 mmol/L. Alta mortalidade esperada.

Insight: Apenas 8% evoluíram para choque séptico, um índice inferior ao de outras UTIs do Nordeste (que chegam a 45%). Isso sugere eficácia nos protocolos iniciais ou diferenças na triagem regional.

qSOFA: O Alerta Rápido Não Invasivo

O Ferramenta

Quick Reference Card

Score ≥ 2 indica alto risco



Alteração Mental
(Glasgow < 15)



Respiração Acelerada
(≥ 22 irpm)



Hipotensão Sistólica
(≤ 100 mmHg)

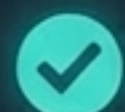
A Realidade Local

Realidade HRN: **48%** dos pacientes apresentaram qSOFA positivo.



qSOFA Positivo

→ Estatisticamente associado ao **ÓBITO**.



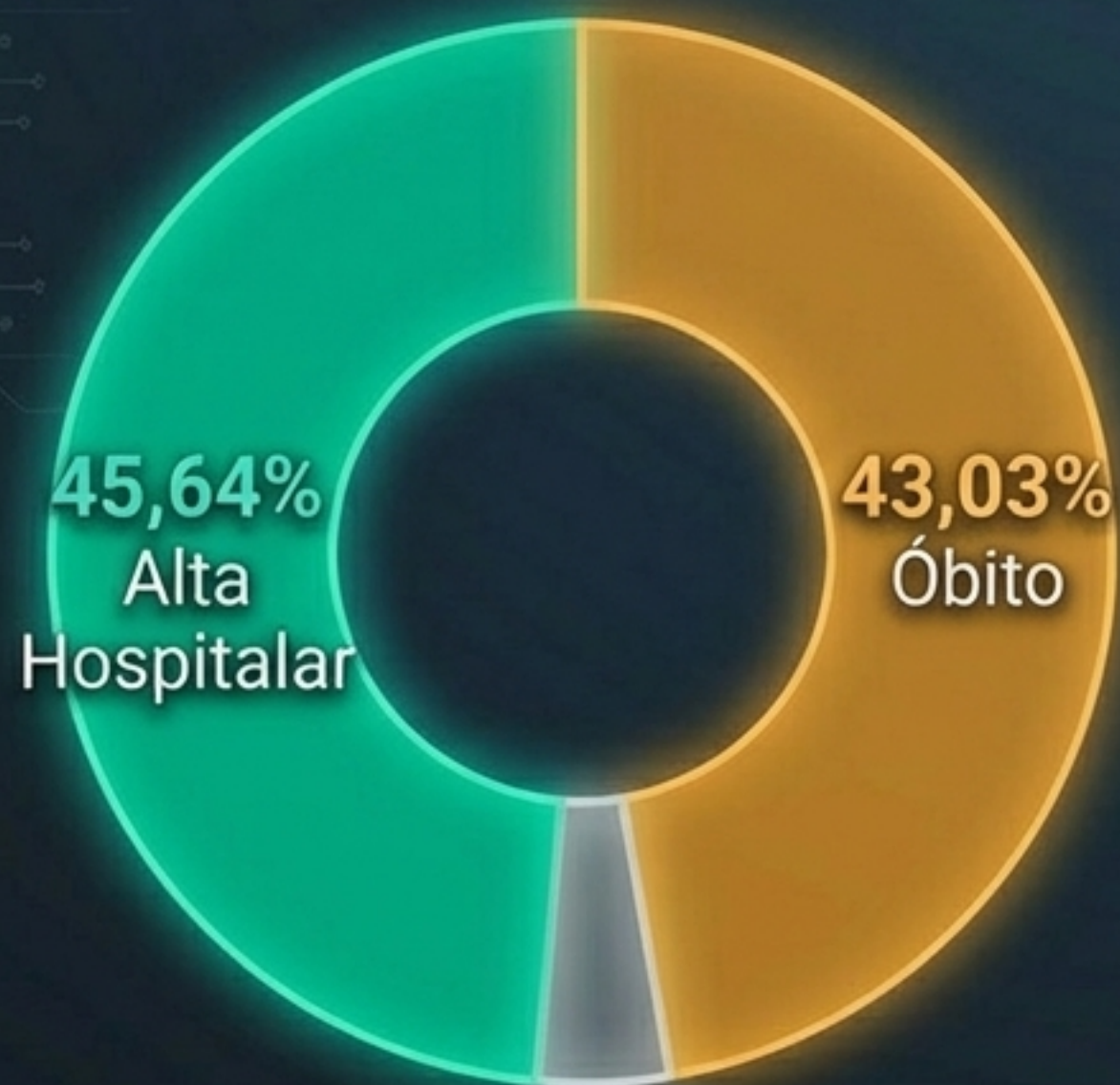
qSOFA Negativo

→ Associado à **ALTA HOSPITALAR**.



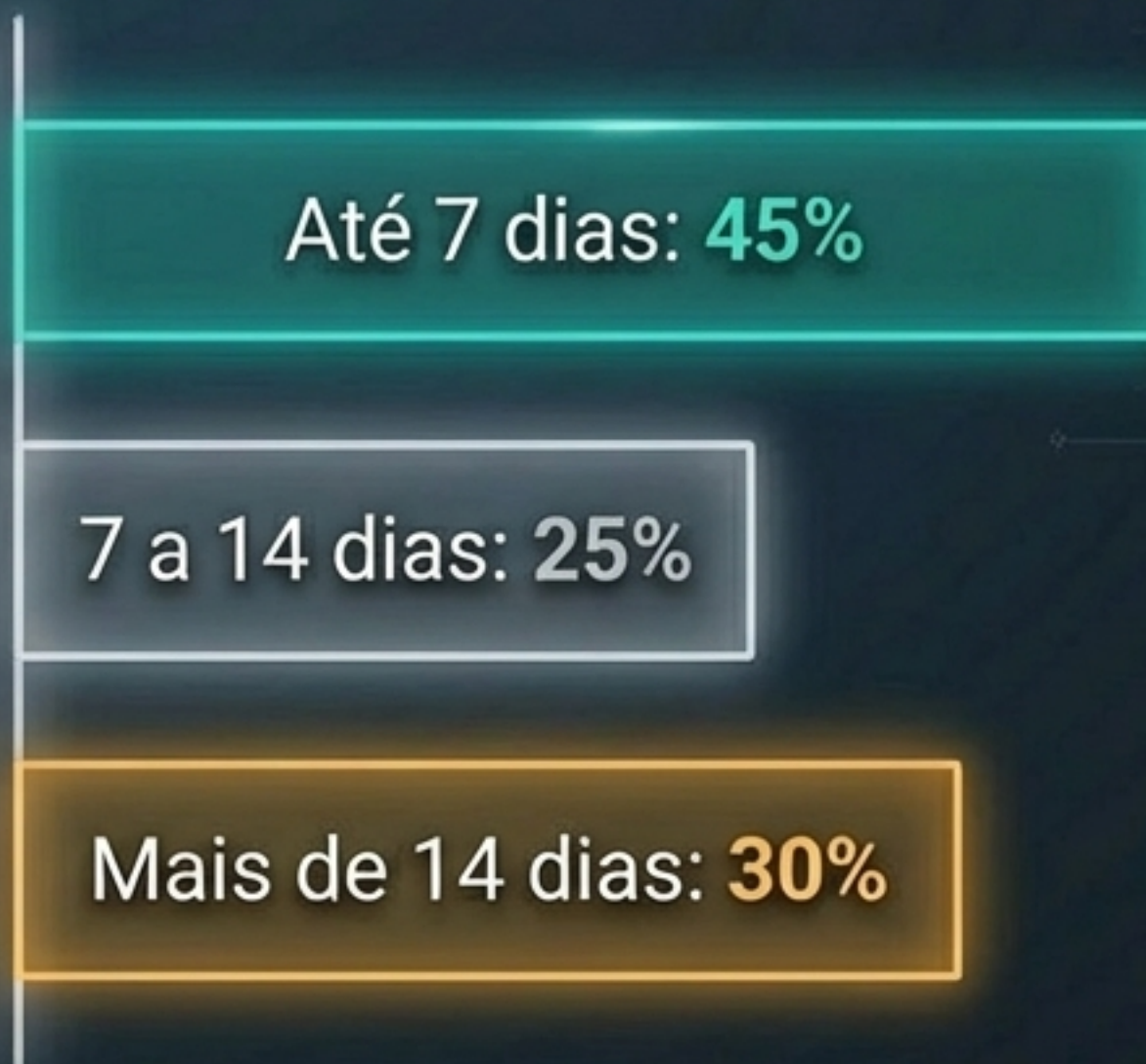
Desfechos e Carga Hospitalar

Morbimortalidade



(Restante: Transferências e Evasão)

Tempo de Internação



(Carga significativa crônica após protocolo agudo)

Auditoria Operacional: Conformidade ao Protocolo



Abertura do protocolo sepse em tempo oportuno.

(Ação de alto engajamento da equipe).



Reavaliação do status volêmico e perfusão.

(Ponto crítico de falha: a ressuscitação inicial acontece, mas o monitoramento contínuo cai)

A Matemática da Sobrevivência

O diagnóstico da sepse comunitária é quase sempre clínico e empírico. Não sabemos o patógeno na hora zero. Mas os dados provam que uma variável controla o destino: **0 Tempo**.

Abertura Oportuna
do Protocolo



$p \leq 0,0001$

Sobrevivência
(Alta Hospitalar)



The Proof

Houve correlação positiva estatisticamente significativa entre a taxa de abertura oportuna do protocolo e a alta hospitalar até 24h.

Insight

A escolha do antibiótico pode ter nuances subjetivas, mas a velocidade da ação operacional é controlável e dita a trajetória de mortalidade.

Diretrizes para a Ação Clínica



1. Foco na “Porta”

Com 67% dos casos originários da comunidade (predominantemente pulmonares), a triagem na Emergência é a verdadeira UTI primária.



2. Confie no qSOFA

Utilize o qSOFA rigorosamente. É uma ferramenta não-invasiva, de baixo custo, que neste estudo dividiu matematicamente os pacientes entre trajetórias de alta e óbito.



3. A Hora de Ouro é Inegociável

A reavaliação hemodinâmica precisa melhorar (hoje em 56%), mas manter o gatilho de abertura do protocolo acima de 89% é a métrica operacional que mais salva vidas no HRN. O segredo da emergência é acertar o diagnóstico a tempo de revertê-lo.